

 Osakidetza TXAGORRITXU OSPITALEA - HOSPITAL TXAGORRITXU ZENTROAREN HELBIDEA / DIRECCION DEL CENTRO HUA-TXAGORRITXU JOSÉ.DE.ATXOTEGUI,S/N 01009 VITORIA-GASTEIZ ARABA/ALAVA - ESPAÑA 945007000	Lehenengo Abizena / Primer Apellido GUINEA Bigarren Abizena / Segundo Apellido IBAÑEZ DE GARAYO IZENA / NOMBRE LUIS MARIA HELBIDEA / Domicilio Bide Mota / Tipo de vía: CALLE Bidearen izena / Nombre de la vía: Tomas Alfaro Bidearen zenbakia / Número de la vía: 13 Pisua / Piso: 007 Letra / Letra: A Posta-Kodea / Código Postal: 1008 Udalerrria / Municipio: Vitoria-Gasteiz Probintzia / Provincia: Álava Herrialdea / País:
LARRIALDIETAKO TXOSTEN KLINIKOA / INFORME CLINICO DE URGENCIAS	

Historia-zk(IKK) / N° Historia Clínica(CIC) 1164816 Europako PIKa / CIP Europeo No disponible Sexua / Sexo Hombre	Autonomia E. PIKa / CIP de C.Autónoma NANa/Bizileku-txartela/Pasaportea / DNI/T.Residencia/Pasaporte 16240664L G. Segurantzako zk. / NASS 010015586764	Jaioteguna / Fecha Nacimiento 15/05/1956 SNS Kodea / Código SNS
Ingresu - eguna eta ordua / Fecha y hora ingreso 13/12/2023 6:15:00 Jatorria / Procedencia IniciativaPropia	Alta eguna eta ordua / Fecha y hora de alta 13/12/2023 7:58:50 Kontsulta-mota / Tipo de consulta ENFERMEDAD	

KONTSULTAREN ARRAZOIA / MOTIVO DE CONSULTA

Hombre de 67 años que acude por Dolor abdominal

AURREKARIAK / ANTECEDENTES

- Sin alergia medicamentosas conocidas.
- HTA y dislipemia en tratamiento farmacológico.
- Primer episodio de FA, revertida con Vernakalant en octubre 2019. Posterior control en CCEE de Cardiología; ecocardiograma en nov/2019 con FE conservada, AI dilatada ligera. Dado de alta en abril/2020.
- Segundo episodio de FA 05/2020 Revertida con Vernakalant. Se inicia edoxaban. Última consulta 24/08/2020.
- Accidente de bicicleta en el año 2003: TCE grave con fractura de base craneal y fractura temporal izquierda. Hematoma epidural temporal izquierdo. Hematoma subdural temporo-parietal izquierdo. Hemorragia subaracnoidea traumática. Importante desviación de línea media con borramiento de cisternas basales. Precisó tratamiento de rehabilitación por presentar una afasia mixta de predominio motor. Discreta hemiparesia derecha.
- Epilepsia. Última crisis en 2010, generalizada tónico clónicas.
- Fístula arteriovenosa dural del seno sigmoide derecho tratada endovascularmente 17 de septiembre de 2018. En control por neuroradiología. Ingresa en junio/19 para control angiográfico con resultado de correcta embolización.
- Antecedentes quirúrgicos:
 Varices (Dic 2017). Sutura tendón mano 2017 con AG, evacuación de hematoma subdural y epidural y craneotomía descompresiva por TCE grave en 2003. Fractura húmero
- Tratamiento habitual:
 - Edoxaban 60 mg 1 comprimido 24 horas
 - Apocard 100mg 2 comprimido 24 horas
 - Atenolol 100mg 1 comprimido desayuno
 - Felodipino 5mg 1 comprimido desayuno
 - Simvastatina 20mg 1 comprimido acostarse
 - Lamotrigina 100mg 1 comprimido desayuno y cena
 - Lorazepam 1mg 1 comprimido acostarse

EGUNGO HISTORIA / HISTORIA ACTUAL

Acude por dolor agudo en epigastrio sin cortejo vegetativo, no irradiado de 1-2 hs de evolución, asociado a náuseas, no vómitos. No dolor torácico, no palpitaciones. No hiporexia ni sdme constitucional en días previos, niega trasgresiones dietéticas, no cambios en el ritmo dps, no otros síntomas en anamnesis por aparatos.

SINATUTA / FIRMADO 1. ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 1: 01107348 MELGAREJO ROA, CLARA NADYNE Kat. Prof. / Cat.Prof.: Medico residente 2. ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 2:	ASISTENTZIA UNITATEA / UNIDAD ASISTENCIAL: URGENCIAS GENERALES SINADURA DATA / FECHA FIRMA: 13/12/2023 SINADURA ORDUA / HORA FIRMA: 7:57 ALDAKETAREN DATA / FECHA MODIFICACION: ORRIA / PÁGINA: 1 / 4
---	--

 Osakidetza	Historia-zk(IKK) / N° Historia Clínica(CIC) 1164816	Jaioteguna / Fecha Nacimiento 15/05/1956	Sexua / Sexo Hombre
	Lehenengo Abizena / Primer Apellido GUINEA	Bigarren Abizena / Segundo Apellido IBAÑEZ DE GARAYO	IZENA/ Nombre LUIS MARIA
	LARRIALDIETAKO TXOSTEN KLINIKOA / INFORME CLINICO DE URGENCIAS		

Comenta que alguna vez ha sufrido episodios parecidos en relación a trasgresiones dietéticas y que ha mejorado con Almax por lo que hoy se ha tomado hasta 3 sobre pero no ha mejorado.

MIAKETA FISIKOA / EXPLORACIÓN FÍSICA

Bien nutrido e hidratado. Buena coloración de piel y mucosas. Eupneico en reposo.

- Constantes vitales:

13/12/2023 07:00 PA 136/76
 13/12/2023 06:50 FC 55 SO2 95
 13/12/2023 06:45 PA 154/85
 13/12/2023 06:30 PA 153/84
 13/12/2023 06:26 FC 53 SO2 99
 13/12/2023 06:24 Temp 34.7

- Cabeza y cuello: Orofaringe normal. No adenopatías. No IY.

- A.C.: Rítmica. No soplos, roces ni extratonos.

- A.P.: Murmullo vesicular conservado sin ruidos sobreañadidos.

- Abdomen: Blando y depresible. Dolor en epigastrio constante y a la palpación. No signos de irritación peritoneal. No masas ni visceromegalias. Peristaltismo conservado. No soplos abdominales. Puño-percusión renal bilateral negativa.

- EE.II.: No edemas. No semiología de TVP. Pulsos pedios presentes y simétricos.

PROBA OSAGARRIAK / PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

ECG: RS a 53 lpm. Eje izquierdo. QRS estrecho sin alteraciones de la repolarización agudas, similar a previos

BIOQUIMICA GENERAL

BIOQUIMICA SUERO

Srm-Glucosa	107 mg/dL	60 - 110
Srm-Urea	31 mg/dL	10 - 50
Srm-Creatinina	0,94 mg/dL	0,5 - 1,4
Srm-Tasa de Filtracion Glomerular (CKD-EPI)	83 mL/min/1.73 m2	> 60

El resultado no es válido en personas < 18 años ni en la insuficiencia renal aguda

En personas de raza negra multiplicar por 1,155

Srm-GOT	38 U/L	2 - 40
Srm-GPT	22 U/L	2 - 45
Srm-Bilirrubina	0,5 mg/dL	<1,3
Srm-Amilasa	44 U/L	25 - 125
Srm-Sodio	142 mEq/L	135 - 146
Srm-Potasio	3,9 mEq/L	3,5 - 5,5
Srm-Cloruro	105 mEq/L	95 - 110
Srm-Proteina C reactiva (PCR)	1,8 mg/L	0,00 - 5,00
Srm-Troponina I cardiaca ultrasensible (TNI)	< 5 ng/L	0 - 34,2

HEMATOLOGIA GENERAL

Sin Seccion

San-Hemograma

San-Hematíes	4,80 *10^6/μL	4,5 - 5,9
San-Hemoglobina	14,8 g/dL	13 - 17,7
San-Hematocrito	45,9 %	40 - 53
San-Volumen corpuscular medio (VCM)	95,7 fL	78 - 101
San-Amplitud de distribucion eritrocitaria		

(ADE) 11,5 % 11,5 - 14,5

San-Hemoglobina corpuscular media eritrocitaria

(HCM) 30,9 pg 27 - 33

San-Concentración de hemoglobina corpuscular

media 32,2 g/dL 30,5 - 35,5

San-Plaquetas 161 *10^3/μL 100 - 450

SINATUTA / FIRMADO 1.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 1: 01107348 MELGAREJO ROA, CLARA NADYNE Kat. Prof. / Cat.Prof.: Medico residente 2.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 2:	ASISTENTZIA UNITATEA / UNIDAD ASISTENCIAL: URGENCIAS GENERALES SINADURA DATA / FECHA FIRMA: 13/12/2023 SINADURA ORDUA / HORA FIRMA: 7:57 ALDAKETAREN DATA / FECHA MODIFICACION: ORRIA / PÁGINA: 2 / 4
---	---

 Osakidetza	Historia-zk(IKK) / N° Historia Clínica(CIC) 1164816	Jaioteguna / Fecha Nacimiento 15/05/1956	Sexua / Sexo Hombre
	Lehenengo Abizena / Primer Apellido GUINEA	Bigarren Abizena / Segundo Apellido IBAÑEZ DE GARAYO	IZENA/ Nombre LUIS MARIA
	LARRIALDIETAKO TXOSTEN KLINIKOA / INFORME CLINICO DE URGENCIAS		

San-Volumen plaquetario medio (VPM)	* 7,0 fL	7,4 - 11
San-Leucocitos	4,91 *10 ³ /μL	4 - 11
San-Formula leucocitaria		
San-Neutrófilos	53,20 %	30 - 70
San-Linfocitos	32,20 %	25 - 50
San-Monocitos	13,10 %	0 - 20
San-Eosinófilos	1,42 %	0 - 5
San-Basófilos	0,06 %	0 - 4
San-Neutrófilos	2,61 *10 ³ /μL	1,5 - 7,7
San-Linfocitos	1,58 *10 ³ /μL	1,1 - 4,5
San-Monocitos	0,64 *10 ³ /μL	0,1 - 1,0
San-Eosinófilos	0,07 *10 ³ /μL	0 - 0,5
San-Basófilos	0,00 *10 ³ /μL	0,0 - 0,4

HEMOSTASIA

Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)	37,6 sg	25,0 - 40,0
Pla-Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPA)(ratio)	1,25	0,80 - 1,30
Pla-Tiempo de protrombina (sg)	* 13,3 sg	10,0 - 13,0
Pla-Tiempo (Indice) de protrombina (%)	82 %	70 - 150
Pla-INR (Ratio Internacional Normalizada)	1,1	0,8 - 1,2
Pla-Fibrinogeno (derivado)	* 510 mg/dL	150 - 500

PROZEDURAK ETA JASOTAKO TRATAMENDUA / PROCEDIMIENTOS Y TRATAMIENTO RECIBIDO

PANTOPRAZOL 40 MG IV
 PRIMPERAN 10 MG IV
 PARACETAMOL 1 G IV

EBOLUZIOA ETA OHARRAK / EVOLUCIÓN Y COMENTARIOS

Tras tratamiento, buena evolución clínica.

DIAGNOSTIKO NAGUSIA / DIAGNÓSTICO PRINCIPAL

Data/Fecha	Sistema/Sistema	Kodea/Código	Diagnostiko nagusia/Diagnóstico principal
13/12/2023	CIE10	R1013	Epigastralgia

BESTE DIAGNOSTIKO BATZUK / OTROS DIAGNÓSTICOS

TRATAMENDUA / TRATAMIENTO

- Omeprazol 20 mg 1 pastilla antes del desayuno y otro por la noche despues de la cena durante 10 días, luego suspender
- Medidas higienico-dietéticas
- Si persisten los sintomas tras tratamiento acudir al MAP
- Se explican signos y síntomas por los que reconsultar.

BESTE GOMENDIO BATZUK / OTRAS RECOMENDACIONES

El diagnóstico emitido en este informe se basa en una valoración de urgencia que no siempre supone un diagnóstico definitivo. Este se alcanza teniendo en cuenta la evolución y el seguimiento del proceso. Para ello, le aconsejamos control evolutivo por su equipo de Atención Primaria.

ALTAREN ARRAZOIA / MOTIVO DE ALTA

SINATUTA / FIRMADO 1.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 1: 01107348 MELGAREJO ROA, CLARA NADYNE Kat. Prof. / Cat.Prof.: Medico residente 2.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 2:	ASISTENTZIA UNITATEA / UNIDAD ASISTENCIAL: URGENCIAS GENERALES SINADURA DATA / FECHA FIRMA: 13/12/2023 SINADURA ORDUA / HORA FIRMA: 7:57 ALDAKETAREN DATA / FECHA MODIFICACION: ORRIA / PÁGINA: 3 / 4
---	---

 Osakidetza	Historia-zk(IKK) / N° Historia Clínica(CIC) 1164816	Jaioteguna / Fecha Nacimiento 15/05/1956	Sexua / Sexo Hombre
	Lehenengo Abizena / Primer Apellido GUINEA	Bigarren Abizena / Segundo Apellido IBÁÑEZ DE GARAYO	IZENA/ Nombre LUIS MARIA
	LARRIALDIETAKO TXOSTEN KLINIKOA / INFORME CLINICO DE URGENCIAS		

SINATUTA / FIRMADO	ASISTENTZIA UNITATEA / UNIDAD ASISTENCIAL: URGENCIAS GENERALES
1.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 1: 01107348 MELGAREJO ROA, CLARA NADYNE Kat. Prof. / Cat.Prof.: Medico residente	SINADURA DATA / FECHA FIRMA: 13/12/2023 SINADURA ORDUA / HORA FIRMA: 7:57 ALDAKETAREN DATA / FECHA MODIFICACION:
2.ARDURADUNAREN IZENA / NOMBRE RESPONSABLE 2:	ORRIA / PÁGINA: 4 / 4

